

УДК: 616.33-006.6-089

Р.И.Лягазов

Национальный Центр Онкологии, Кыргызстан

Непосредственные результаты хирургического лечения рецидивов рака желудка

Аннотация: Цель исследования - улучшение непосредственных результатов лечения больных с рецидивами рака желудка в зависимости от первичного объема оперативного вмешательства. В торакальном отделении Национального центра Онкологии с 2002 по 2014 гг. проведен ретроспективный и проспективный анализ у 97 больных с установленным морфологическим диагнозом рецидив рака желудка.

Ключевые слова: рак желудка, рецидив.

Актуальность. Рак желудка остается одним из основных жизнеугрожающих онкологических заболеваний человека в XXI веке и занимает третье место в структуре онкологических заболеваний после легких, трахеи и бронхов. Ежегодно в мире диагностируется до 800 тыс. новых случаев заболевания, причем аденокарцинома желудка занимает второе место в онкологической патологии, уступая лишь раку легкого. (1,2,3). В ряде стран этот показатель особенно высок – в Японии 114,7 случаев на 100 тыс. населения, в России – 51,5 случаев на 100 тыс. населения.

В Кыргызстане рак желудка занимает первое место в структуре онкологической патологии: его распространенность составляет 12,1 случаев на 100 тыс. населения, а смертность 9,6 случаев на 100 тыс. населения. Особую роль в борьбе с раком желудка играет разработка вопросов диагностики, лечения, профилактики рецидивов заболевания, являющейся зачастую причинной смерти больных (11,12).

Основным радикальным методом лечения остается хирургический, использующийся у большинства данной категории больных (4,5,6).

В настоящее время в ведущих онкологических центрах лечении рецидивов уделяется большое внимание (7,8,9,10). Несмотря на достигнутые результаты в плане диагностики и лечения рака желудка, до сих пор нет единого мнения в показаниях противопоказаниях к повторным операциям, что привело нас к более детальному изучению данной проблемы.

Материал и методы. В торакальном отделении Национального центра онкологии проведено ретроспективное и проспективное исследование у 97 больных с рецидивом рака желудка. За период с 2002 по 2014 гг. Больные были разделены на три группы в зависимости от вида лечения:

1. Группа «А», включала 37 (38,2%) больных, получивших повторное хирургическое лечение.

2. Группа «Б», состояла из 30 (30,9%) пациентов, которым проводилась системная химиотерапия, в качестве которой использовались Этопозид 200 мг, цисплатин 50 мг и Фторурацил 750 мг, препараты вводились через день, всего курсов 3.

3. Группа «С» – 30 (30,9%): пациентов которые получили только симптоматическое лечение.

В группе «А», Возраст больных варьировал от 50-79 лет. Между мужчинами и женщинами рецидив возник равнозначно. Большинство больных составляют лица молодого и трудоспособного возраста. У всех больных диагноз подтвержден гистологическим исследованием аденокарцинома низкой степени дифференцировки выявлена у 13 (35,3%) больных, а у 24 (64,7%) больных представлены перстневидно-клеточным раком.

Таблица 1 - Объемы первичного хирургического вмешательства при раке желудка

Тип операции и объем первичной операции	Количество больных
дистальная субтотальная резекция желудка	14 (37,8%)
проксимальная субтотальная резекция желудка	16 (43,2%)
гастрэктомия	7 (18,9%)
всего	37 (100%)

Как показано в таблице 1 в зависимости от первично выполненных оперативных вмешательств было выявлено у дистальной субтотальной резекции желудка (ДСРЖ) 14 (37,8%) больных, после проксимальной субтотальной резекции желудка (ПСРЖ) у 16 (43,2%) больных, а у 7-больных (18,9%) после гастрэктомии (ГЭ). Основное количество больных составило после проксимальных и дистальных резекций желудка.

Таблица 2 - Объемы повторных хирургических вмешательств при рецидивах рака желудка

Повторные операции	Количество больных
экстирпация культи желудка	12 (32,4%)
обходные анастомозы	10 (27,0%)
эксплоративная лапаротомия	10 (27,0%)
Гастростомия энтеростомия по майдлю еюностомии	5 (13,5%)
всего	37 (100%)

Как показано в таблице 2 лишь 12 (32,4%) больным удалось выполнить радикальную операцию в объеме экстирпации культи. В остальных случаях носил паллиативный характер, что в свою очередь помогает улучшить качество жизни больным.

Рецидивы были разделены от момента возникновения на ранние и поздние.

Таблица 3 - Сроки развития рецидивов

Сроки возникновения рецидивов	6мес-3года	3года и более
муж	13(35,3%)	9(24,3%)
жен	11(29,7%)	4(10,8%)
Всего 37(100%)	24(64,8%)	13(35,3%)

Из таблицы 3 видно, что ранний рецидив, возник в первые, 3 года с момента первой операции в количестве 24 (64,8%) больных. А поздний составил 13 (35,5%) больных. При анализе сроков возникновения рецидивов после лечения в ряде литературных источников подвергается сомнению корректность термина «безрецидивный период». В нашем исследовании мы условно считали безрецидивным периодом время, прошедшее с момента операции до появления первых признаков развития рецидива, то есть до возникновения клинических проявлений, либо при отсутствии таковых до выявления рецидива при динамическом обследовании больных. Средняя продолжительность безрецидивного периода во всей исследуемой группе (37 больных) составила $26,1 \pm 3,2$ мес.

Результаты исследования и их обсуждение.

В результате проведенного исследования, были получены следующие данные. При сравнительной оценке послеоперационных осложнений после повторных вмешательств.

Таблица 4 -Осложнения в хирургической группе

Послеоперационные осложнения	Количество больных	летальность
кровотечения	1(2,7%)	-
пневмонии	2(5,4%)	-
Несостоятельность шва анастомоза	2(5,4%)	2 (5,4)%
нет	31(83,8%)	-
всего	37(100%)	2 (5,4)%

Как показано в таблице 4 у 1 больного развилось послеоперационное кровотечение которое было устранено ретораколапоротомией, у 2 больных пневмонии и самое грозное осложнение несостоятельность швов анастомоза развилось у 2 (5,4%) больных которые имели место летального исхода.

Таблица 5 - Развитие осложнений после химиотерапии

Осложнения после химиотерапии.	Количество больных	3года и более
Диспепсические расстройства	2 (6,66%)	9(24,3%)
анемия	2 (6,67%)	4(10,8%)
аллопеция	3 (10%)	13(35,3%)
Диарея	3 (10%)	
Общая слабость, недомогание	5 (16,6%)	
нет	15 (50)%	
всего	30 (100%)	

Все побочные действия химиотерапии купировались симптоматическим лечением.

Несмотря на все трудности, сопутствующие хирургическому лечению рецидивов рака желудка, попытки повторного оперативного вмешательства полностью оправдывают себя, и непосредственные результаты сопоставимы с таковыми при лечении первичного рака желудка.

Таким образом, в ходе проведенного ретроспективного, проспективного исследования было установлено, что данная категория больных остаётся самой сложной и требующей к себе внимания так и индивидуального подхода в плане дальнейшей тактики обследования и лечения.

Список литературы

1. Ахметзянов Ф.Ш., Борисов В.П. Профилактика некоторых послеоперационных осложнений после гастрэктомий по поводу рака желудка // Матер. VII съезда онкологов РФ. - М., 2009. - Т. 1. - С. 281.
2. Ахметзянов Ф.Ш., Китаев М.Р. Обоснование объема хирургического вмешательства при раке дистального отдела желудка // Креативная хирургия и онкология. - 2010. - №2. - С. 40-42.
3. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2012 году/Под ред. М.И.Давыдова, Е.М.Аксель; ГУРОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН. - М.: Медицинское информационное агентство, 2009. - С.95-97, 223-224.
4. Давыдов М.И., Тер-Ованесов. Современная стратегия хирургического лечения рака желудка // Современная онкология. - 2008. - Т.2, N1. - С.4-10.
5. Давыдов М.И., Туркин И.Н., Стилиди И.С. и др. Кардиоэзофагеальный рак: классификация, хирургическая тактика, основные факторы прогноза // Вестник РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. - 2006. - №1. - С.82-89.
6. Черноусов А.Ф., Поликарпов С.А., Годжело Э.А. Ранний рак и предопухолевые заболевания желудка. - М.: ИздАТ, 2009. - 256 с.
7. Гарин А.М., Базин И.С., Нариманов М.Н. Обзор возможностей химиотерапии рака желудка // Русский мед. журнал. - 2011. - Т. 9, №22. - С. 989-991.
8. Van Cutsem E.J.D., Ajani J., Tjulandin S. et al. Docetaxel in combination with cisplatin with or without 5-fluorouracil in patients with advanced gastric or GE junction adenocarcinoma: preliminary results // ESMO, 2004, Hamburg, ab. 276.
9. Roth A.D., Maibach R., Marinelli G. et al. Taxotere-cisplatin in advanced gastric carcinoma: an active drug combination // Proc. ASCO. - 2005, ab. 1088.
10. Aiko Takashi and Mitsuru Sasako. The General Rules' Committee of the Japanese Gastric Cancer Association. The new Japanese Classification of Gastric Carcinoma: Points to be revised // Gastric. Cancer. - 2007. - No. 1. - P. 25-30.
11. Bonenkamp J. J., Hermans J., Sasako M., van de Velde C. J. H. Quality Control of Lymph Node Dissection in the Dutch Randomized Trial of D1 and D2 Lymph Node Dissection for Gastric Cancer // Gastric Cancer. - 2007. - No. 1. - P. 152-159.
12. Egashira Yutaro, Tadakazu Shimoda, Masahiro Ikegami. Mucin histochemical analysis of minute gastric differentiated adenocarcinoma // Pathology International. - 2008. - Т. 49. - С. 55-61.

Тұжырым
Р.И.Лягазов

ҚР ДСМ Ұлттық онкология орталығы,
Бішкек қ.

Рецидивті асқазанның қатерлі ісігінің хирургиялық емінің тікелей нәтижелері

Зерттеудің мақсаты - рецидивті асқазанның қатерлі ісігі бар науқастардың біріншілік оперативті емінің көлеміне байланысты, тікелей нәтижелерін жақсарту. Ұлттық онкология орталығында 2002-2014жж. аралығында, торакальды бөлімшеде емделген, рецидивті асқазанның қатерлі ісігі бар 97 науқасқа (морфологиялық диагнозы бар) ретроспективті және проспективті сараптамасы жүргізілді.

Түйінді сөздер: рецидив, асқазанның қатерлі ісігі.

Summary

Lyagazov R.I.

National Oncology Center MH of Kyrgyzstan

The immediate results of surgical treatment of gastric cancer recurrence

Objective: Improvements to the immediate results of treatment of patients with recurrent gastric cancer, depending on the volume of the primary surgery. In the thoracic department of the National Center of Oncology from 2002 to 2014. A retrospective and prospective analysis of 97 patients with an established diagnosis of morphological relapse of stomach cancer.

Keywords: stomach cancer relapse.